

정신·감정·영적 생활방식 인자 — 패널 Q&A;

진행자 | Dr. Jennifer Jackson · Dr. David Haase

섹션 1. 생활방식 변화를 위한 공동 우선순위 설정

진행자

이 세션은 수정 가능한 생활방식 인자와 정신·감정·영적 요소에 초점을 맞춘 Q&A; 패널입니다. GOTOIT의 ORDER 단계에서 배운 것처럼, 환자와 함께 생활방식 개입의 우선순위를 공동으로 설정하기 위해 임상가가 어떻게 소통하는지에 대해 Jennifer 선생님부터 시작해 주세요.

Dr. Jennifer Jackson

저는 환자들이 두 부류로 나뉜다고 생각해요. 한 쪽은 지금 당장 모든 것을 바꾸고 싶은, 준비된 환자들이고, 다른 쪽은 "글쎄요, 잘 모르겠어요. 일단 발가락만 담가보는 식으로 해볼까요"라고 말하는 환자들이죠. 둘 다 괜찮습니다. 핵심은 환자가 있는 곳에서 만나는 것이에요. 환자가 처음에 바꿀 수 있다고 보는 목표와 영역을 먼저 찾아야 해요. 제 목표는 중요하지 않아요. 환자가 가장 잘 알고 있으니까요.

Dr. David Haase

공동 우선순위 설정은 먼저 소통이 이루어져야 합니다. 그 과정은 진료의 첫 순간부터 시작돼요. 어떻게 눈을 마주치고, 악수하고, 이름을 불러주고, 따뜻한 분위기를 만드는지가 중요합니다. 사람들은 당신이 말하는 것보다 자신이 느끼는 것을 훨씬 더 많이 받아들여거든요. 결국 당신의 마음에서 나오는 거예요. 내가 정말 이 사람을 공동 의사결정자로 삼고 싶은가? 전문가로 훈련받은 우리로서는 쉽지 않지만, 환자 스스로 아이디어를 내지 않으면 실제로 변화는 일어나지 않아요. 결과에 헌신하려면, 영혼 있는 소통(soulful communication)을 통한 공동 우선순위 설정에서 시작해야 합니다.

진행자 (환자 이야기 다시 말해주기에 대해)

영혼 있는 소통은 환자의 이야기를 되돌려 말해주는 것도 포함되죠. 공동 의사결정을 어떻게 설정하나요?

Dr. David Haase

환자가 "당신이 내 말을 들었구나"라고 느끼는 것 자체가 치유입니다. 환자의 이야기를 다시 들려줄 때, "아, 맞아요, 그렇죠" 같은 다양한 단서들을 얻게 됩니다. 어떤 검사 결과보다 훨씬 더 중요한 정보예요. 그 반응을 통해 환자는 자신의 자원을 인식하고, 그 자원을 가장 효과적으로 활용하고 우선순위를 정할 수 있게 됩니다.

섹션 2. 생활방식 인자별 최선의 접근법

진행자

이제 구체적인 개입으로 넘어가겠습니다. 수면·운동·스트레스·관계에서 어떤 접근법이 가장 도움이 되나요?

Dr. David Haase

저는 수면을 우선시합니다. 수면을 이야기하면 다른 모든 것을 함께 이야기할 수 있거든요. 또한 수면은 저항감이 적어요. 모두가 더 잘 자고 싶어하니까요. 그래서 수면을 시작점으로 삼기 좋습니다.

Dr. Jennifer Jackson

동감해요. 수면에서 변화를 만들지 못하면 나머지가 작동하지 않아요. 영양부터 시작하고 싶지만, "지금 자고 있나요? 잠들 수 있나요? 계속 자나요? 질 좋은 수면을 취하나요?"를 먼저 물어야 해요. 웨어러블 기기가 이 부분에서 굉장히 유용할 수 있어요. 기본적인 수면 위생—핸드폰을 침대 옆에 놓는 것, 고양이나 강아지가

깨우는 것—을 먼저 다루고, 이후 심화 모듈에서 더 다룰 것들이 있습니다.

Dr. David Haase (생활방식 인자 통합하기)

"수면부터 시작합니다"에 동의했다면, 저는 이렇게 합니다: "아침 일찍 또는 새벽·황혼 시간에 야외에 나가보는 건 어때요? 광생물조절(photobiomodulation) 효과가 있거든요. 나가는 김에 조금 걷는 건요? 그게 움직임도 되고요. 자기 전에 깊게 숨 몇 번 쉬는 것, 그게 스트레스에도 도움이 돼요. 잠자리에 들 때 오늘 누군가와 나눈 긍정적인 연결을 떠올리고, 내일 만들 연결을 생각해 보세요." 이렇게 하면 수면을 출발점으로 운동·스트레스·관계를 자연스럽게 연결할 수 있어요. 마찰이 조금 더 있는 생활방식 인자들로 환자를 데려오는 방법이죠.

Dr. David Haase (강점 목록)

환자에게 강점을 인식시켜주세요. "당신은 계획 실행력이 정말 뛰어나군요. 주의를 기울이는 능력이 대단해요. 지지해주는 가족이 있네요. 일정을 조정할 여지가 있고요." 우리는 보통 문제 목록(problem list)만 가지고 있는데, 환자를 위한 강점 목록(strengths list)도 필요해요. 첫 번째 만남에서 제가 원하는 것은 보장된 성공이에요. 작은 첫 발걸음 하나가 다음 발걸음을 가능하게 합니다. 첫 발이 실패하면, 환자는 "또 실패했어. 안 되는구나"라며 자책할 또 하나의 이유가 생기거든요.

Dr. Jennifer Jackson

David 선생님 말씀에서 제가 진료에서 쓰기 시작한 것이 생각났어요. 평생 훈련받은 대로 "당신의 무엇이 잘못됐나"를 찾는 대신, "당신의 무엇이 강한가(What's strong with you?)"를 묻기 시작했어요. wrong → strong. 이것이 제 개인적인 원동력이 되었고, 훨씬 좋은 결과를 냈어요.

섹션 3. 정신·감정·영적 영역 접근법

진행자

이제 생활방식에서 정신·감정·영적 영역으로 넘어갑니다. 마찰이 훨씬 더 많은 영역이죠. 어떤 소통 기술이나 접근법을 사용하시나요? 환자가 준비됐는지 어떻게 아시나요?

Dr. Jennifer Jackson

타임라인을 들으면서 환자가 먼저 꺼내는 이야기가 있어요. 그걸 꺼내는 순간, 그것에 대해 더 물어볼 수 있는 안전한 공간이 생긴 거예요. 설문에서 스트레스 해소 방법이나 의미 있는 활동을 묻는 것도 있어요. 많은 환자들이 영적 경험을 적극적으로 이야기해요. 그들은 그게 괜찮다는 것, 제가 기꺼이 듣는다는 것을 알아야 해요. 저는 그들의 여정을 목격하는 자리에 있는 사람이에요.

Dr. David Haase

"저는 정신·감정·영적 문제를 이야기하는 것이 매우 편합니다. 그것이 의료의 중요한 부분이라고 생각해요." 이렇게 씨앗을 심어두면, 환자들은 알아서 길을 선택해요. 환자가 주도하게 하면 훨씬 더 나은 곳에 도달해요. 저는 "나는 스위스예요"라고 말하곤 해요—진료실에서는 어떤 표현도 괜찮아요. 환자와의 관계는 신성한 것이고, 환자가 최선의 자신이 될 수 있도록 그 만남의 결과로 이끌고 싶어요.

섹션 4. 임상 핵심 팁 — 정신·감정·영적 도구

진행자

기능의학 훈련 후 인지·감정·영성에 도움이 된 구체적인 도구가 있으신가요?

Dr. David Haase

자기애(self-love)에 대해 묻는 것이 가장 강력해요. "당신은 자신을 좋아하나요? 사랑하나요?" この 질문은 굉장한 힘을 가지고 있어요. "당신을 가장 사랑하는 사람들이 당신을 보는 것처럼 자신을 느낀다면 어떻게 살 것 같나요?" 그 다음은 심박변이도(Heart Rate Variability, HRV)입니다. 자율신경계 조절, 장-뇌 축, 투쟁-도피 vs. 휴식-회복 상태. 저는 호흡 조절(paced breathing)로 시작해요. "지금 이 순간 내가 하는 것으로 나는 다르게 느낄 수 있다"는 첫 번째 인식을 심어주는 거죠.

Dr. Jennifer Jackson

"큰 이유(big why)"를 찾도록 도와주는 것이요. 환자들은 "살 빼고 싶어요, 콜레스테롤 낮추고 싶어요"라고 오지만, 그것이 진짜 이유는 아니에요. 진정으로 중요한 것, 진정으로 가치 있는 것을 찾으면 정신사회적·영적 영역이 자연스럽게 따라와요. 그 "왜"는 종종 그 영역에 있거든요.

진행자 (마지막 팁)

"시간(time)"을 활용해요. "하루 중 자신을 위한 시간을 어떻게 보내나요?"라는 질문이에요. "시간"은 중립적인 주제라서 누구나 부담 없이 받아들여요. 이것이 제 단골 진입점입니다.

다음 챕터: 영양(Nutrition)으로 이어집니다.